JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, MENTION ONCOLOGIE ET HÉMATO-ONCOLOGIE

Raisonnement clinique IPA · Oncologie et hémato-oncologie

Un jeu de 52 cartes pour la mention « Oncologie et hémato-oncologie ». Chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique, chaque valeur à une situation clinique suivie à travers un même patient. Chaque carte indique les compétences IPA qu'elle mobilise. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données à la coordination du parcours.

Les 4 couleurs = 4 étapes

♥	**Cœur — Recueillir** Anamnèse, écoute, contexte de vie
♦	**Carreau — Repérer & hypothèses** Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges
♣	**Trèfle — Vérifier** Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
♠	**Pique — Agir & suivre** Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Les 13 valeurs = 13 situations

2	Thérapie orale : capécitabine
3	Neutropénie fébrile
4	Mucite et radiochimiothérapie
5	Nausées et vomissements chimio-induits
6	Immunothérapie : effets immuno-médiés
7	Douleur cancéreuse
8	Fatigue et activité physique adaptée
9	Dénutrition en oncologie
10	Thrombose et cancer
V	Hémopathie : thérapie ciblée orale
D	Neuropathie chimio-induite
R	Après-cancer
A	Soins palliatifs précoces

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de la neutropénie fébrile »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (dénutrition et mucite, douleur et soins palliatifs…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Leadership & recherche** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une situation et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, drapeaux rouges
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : ce qui relève de l'IPA, de la concertation, de l'orientation

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations connues en octobre 2026 (HAS, sociétés savantes, référentiels de la mention), sans vérification en ligne carte par carte ; les cas sont illustratifs. Les conduites thérapeutiques s'entendent dans le cadre des protocoles et de la réglementation en vigueur. À vérifier et actualiser par l'équipe pédagogique avant usage.

MENTION ONCOLOGIE ET HÉMATO-ONCOLOGIE

Compétences et situations

La mention oncologie et hémato-oncologie couvre le suivi des patients atteints de cancer ou d'hémopathie maligne : surveillance des traitements (chimiothérapie, thérapies orales, immunothérapie), repérage et gestion des toxicités, soins de support, prévention, après-cancer et coordination du parcours ville-hôpital.

Les 6 compétences IPA mobilisées

Code	Compétence	Où dans le jeu
C1	Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées	♥ ♦ ♣
C2	Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé	♣ ♠
C3	Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique	♦ ♠
C4	Organiser les parcours de soins et de santé en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés	♠
C5	Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques en exerçant un leadership clinique	Joker 2, repères ♠
C6	Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques	Joker 2, débriefing

Chaque carte porte en en-tête les compétences qu'elle mobilise en priorité. Les compétences C5 et C6 sont travaillées avec le joker « Leadership & recherche » et lors du débriefing.

Les 13 situations cliniques

2	**Thérapie orale : capécitabine** Mme L., 63 ans, cancer colique métastatique, débute de la capécitabine. C'est sa première consultation de suivi infirmier.
3	**Neutropénie fébrile** M. N., 55 ans, traité pour un lymphome, est à J9 de sa chimiothérapie. Il appelle : « J'ai 38,4 °C et des frissons. »
4	**Mucite et radiochimiothérapie** Mme M., 48 ans, cancer ORL, est en radiochimiothérapie depuis 3 semaines. Elle mange de moins en moins.
5	**Nausées et vomissements chimio-induits** Mme K., 39 ans, cancer du sein, a reçu sa première cure (anthracycline et cyclophosphamide). Elle a beaucoup vomi les jours suivants.
6	**Immunothérapie : effets immuno-médiés** M. I., 66 ans, mélanome métastatique, reçoit un anti-PD-1 depuis 4 mois. Il signale de la fatigue et des selles plus fréquentes.
7	**Douleur cancéreuse** M. D., 70 ans, cancer de la prostate avec métastases osseuses, a des douleurs lombaires qui l'empêchent de dormir.
8	**Fatigue et activité physique adaptée** Mme F., 52 ans, a terminé sa chimiothérapie pour un cancer du sein il y a 2 mois. Elle se dit « épuisée » et ne reprend pas le travail.
9	**Dénutrition en oncologie** M. E., 68 ans, cancer du pancréas, débute une chimiothérapie. Il a perdu 7 kg en un mois.
10	**Thrombose et cancer** Mme T., 59 ans, cancer de l'ovaire sous chimiothérapie, a le mollet gauche gonflé et douloureux depuis 2 jours.
V	**Hémopathie : thérapie ciblée orale** M. H., 74 ans, leucémie lymphoïde chronique, prend de l'ibrutinib depuis 6 mois. Il vient pour son suivi infirmier.
D	**Neuropathie chimio-induite** Mme O., 56 ans, cancer du côlon, reçoit de l'oxaliplatine. Elle a des fourmillements des doigts au froid.
R	**Après-cancer** M. R., 58 ans, a terminé le traitement d'un cancer du poumon il y a 6 mois. Il vient pour la consultation de fin de traitement.
A	**Soins palliatifs précoces** Mme P., 71 ans, cancer du poumon métastatique en progression après deux lignes de traitement, est plus fatiguée et essoufflée.

2 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Thérapie orale : capécitabine

Compétences IPA : C1

Mme L., 63 ans, cancer colique métastatique, débute de la capécitabine. C'est sa première consultation de suivi infirmier.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Compréhension du schéma : cycles, prises, moment des repas
- Observance, gestion des oublis, capacité à manipuler les comprimés
- Autres traitements, automédication, phytothérapie (interactions)
- Fonction rénale, poids, état général (OMS)
- Entourage, ressources, lien avec le pharmacien d'officine

2 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Thérapie orale : capécitabine

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme L., 63 ans, cancer colique métastatique, débute de la capécitabine. C'est sa première consultation de suivi infirmier.

À J10, paumes rouges et douloureuses, 4 selles liquides par jour (contre 1 habituellement).

? Quelles toxicités identifiez-vous ? Comment les gradez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Syndrome main-pied et diarrhée : toxicités des fluoropyrimidines
- Gradation selon la classification CTCAE (grades 1 à 4)
- Diarrhée : + 4 à 6 selles/jour par rapport à l'habitude = grade 2
- Main-pied douloureux limitant les activités instrumentales = grade 2

2 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Thérapie orale : capécitabine

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme L., 63 ans, cancer colique métastatique, débute de la capécitabine. C'est sa première consultation de suivi infirmier.

Pas de fièvre, pas de sang dans les selles. Elle se sent fatiguée.

? Quels éléments recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Déshydratation : PA, FC, diurèse
- Ionogramme, créatinine ; NFS (neutropénie associée ?)
- Dépistage du déficit en DPD (uracilémie) réalisé avant traitement : à vérifier
- Gravité : fièvre, rectorragies, douleurs abdominales, ≥ 7 selles/jour

2 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Thérapie orale : capécitabine

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme L., 63 ans, cancer colique métastatique, débute de la capécitabine. C'est sa première consultation de suivi infirmier.

Toxicités de grade 2, sans déshydratation.

? Quelle conduite à tenir et quel suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Suspension jusqu'au grade ≤ 1, reprise selon le protocole, avec l'oncologue
- Diarrhée : hydratation, lopéramide selon protocole ; main-pied : émollients, éviter frottements et chaleur
- Consignes écrites : quand et qui appeler
- Suivi téléphonique rapproché, lien avec le pharmacien d'officine
- Traçabilité des toxicités (données pour l'amélioration des pratiques)

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Neutropénie fébrile

Compétences IPA : C1

M. N., 55 ans, traité pour un lymphome, est à J9 de sa chimiothérapie. Il appelle : « J'ai 38,4 °C et des frissons. »

? Quelles données recueillez-vous au téléphone ?

REPÈRES ATTENDUS

- Température (deux mesures), frissons, date de la dernière cure
- Gravité : malaise, marbrures, confusion, dyspnée
- Point d'appel : toux, brûlures urinaires, diarrhée, cathéter
- Facteur de croissance prescrit ? Antibiotique en cours ?

3 ♥ Ɛ

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Neutropénie fébrile

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. N., 55 ans, traité pour un lymphome, est à J9 de sa chimiothérapie. Il appelle : « J'ai 38,4 °C et des frissons. »

Il a une chambre implantable et se sent « très faible ».

? Quelle hypothèse ? Quel niveau d'urgence ?

REPÈRES ATTENDUS

- Neutropénie fébrile suspectée (nadir entre J7 et J14) : urgence
- Fièvre ≥ 38,3 °C une fois ou ≥ 38 °C pendant 1 heure
- Risque d'évolution rapide vers un sepsis grave
- Évaluation médicale le jour même, sans attendre

3 ♦ Ɛ

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Neutropénie fébrile

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. N., 55 ans, traité pour un lymphome, est à J9 de sa chimiothérapie. Il appelle : « J'ai 38,4 °C et des frissons. »

Il est adressé aux urgences de l'hôpital de référence.

? Quels examens sont attendus ?

REPÈRES ATTENDUS

- NFS : polynucléaires neutrophiles < 0,5 G/L (ou baisse attendue)
- Hémocultures périphériques et sur chambre, ECBU, radio thoracique selon signes
- Lactates, CRP, fonction rénale
- Évaluation du risque (score MASCC)

3 ♣ Ɛ

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Neutropénie fébrile

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. N., 55 ans, traité pour un lymphome, est à J9 de sa chimiothérapie. Il appelle : « J'ai 38,4 °C et des frissons. »

Neutropénie fébrile confirmée, sans signe de gravité, à faible risque (MASCC élevé).

? Quelle prise en charge et quelle prévention pour la suite ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antibiothérapie probabiliste dans l'heure ; ambulatoire possible si faible risque, selon protocole
- ETP : prise de température, numéro à appeler, pas d'antipyrétique avant d'appeler
- Facteurs de croissance aux cures suivantes si prescrits
- Hygiène, vaccination antigrippale de l'entourage
- Analyse du délai d'appel en équipe (amélioration des pratiques)

3 ♠ Ɛ

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

4 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Mucite et radiochimiothérapie

Compétences IPA : C1

Mme M., 48 ans, cancer ORL, est en radiochimiothérapie depuis 3 semaines. Elle mange de moins en moins.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Douleur buccale (EVA), retentissement sur l'alimentation
- Hygiène bucco-dentaire, bains de bouche utilisés
- Poids, apports, hydratation
- Tabac, alcool
- Sécheresse buccale, troubles du goût

Raisonnement clinique · IPA OHO

4 ♠

4 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Mucite et radiochimiothérapie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme M., 48 ans, cancer ORL, est en radiochimiothérapie depuis 3 semaines. Elle mange de moins en moins.

Ulcérations étendues, alimentation liquide seulement ; – 6 % de poids en 3 semaines.

? Comment évaluez-vous la sévérité ?

REPÈRES ATTENDUS

- Mucite de grade 3 (OMS : alimentation liquide seule)
- Dénutrition : perte ≥ 5 % en 1 mois
- Risque de déshydratation et d'interruption du traitement
- Surinfection possible : candidose, herpès

Raisonnement clinique · IPA OHO

4 ♦

4 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Mucite et radiochimiothérapie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme M., 48 ans, cancer ORL, est en radiochimiothérapie depuis 3 semaines. Elle mange de moins en moins.

Dépôts blanchâtres sur la langue.

? Que recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Candidose buccale (prélèvement si doute)
- Déshydratation : créatinine, ionogramme
- Évaluation nutritionnelle, albuminémie
- Besoin d'antalgiques de palier supérieur

Raisonnement clinique · IPA OHO

4 ♣

4 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Mucite et radiochimiothérapie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme M., 48 ans, cancer ORL, est en radiochimiothérapie depuis 3 semaines. Elle mange de moins en moins.

Elle a peur que le traitement soit arrêté.

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antalgie adaptée, y compris opioïde, selon protocole ; bains de bouche au bicarbonate
- Antifongique si candidose, sur prescription
- Textures adaptées, compléments ; discuter une nutrition entérale
- Hygiène buccale douce ; arrêt du tabac et de l'alcool
- Coordination radiothérapeute, diététicien, dentiste

Raisonnement clinique · IPA OHO

4 ♥

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Nausées et vomissements chimio-induits

Compétences IPA : C1

Mme K., 39 ans, cancer du sein, a reçu sa première cure (anthracycline et cyclophosphamide). Elle a beaucoup vomi les jours suivants.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Chronologie : aiguë (< 24 h), retardée (> 24 h), anticipatoire
- Nombre de vomissements, capacité à boire et à manger
- Prise réelle des antiémétiques prescrits
- Facteurs de risque : femme jeune, mal des transports, nausées de grossesse, anxiété
- Poids, fatigue, moral

Raisonnement clinique · IPA OHO

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Nausées et vomissements chimio-induits

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme K., 39 ans, cancer du sein, a reçu sa première cure (anthracycline et cyclophosphamide). Elle a beaucoup vomi les jours suivants.

Vomissements de J2 à J4 ; elle n'a pas pris l'antiémétique « pour ne pas prendre trop de médicaments ».

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Nausées-vomissements retardés d'une chimiothérapie hautement émétisante
- Prophylaxie non suivie : défaut d'information ou croyances
- Facteurs de risque individuels élevés
- Risque de nausées anticipatoires aux cures suivantes

Raisonnement clinique · IPA OHO

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Nausées et vomissements chimio-induits

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme K., 39 ans, cancer du sein, a reçu sa première cure (anthracycline et cyclophosphamide). Elle a beaucoup vomi les jours suivants.

Elle a perdu 2 kg ; pas de douleur abdominale.

? Que vérifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Déshydratation : PA, FC, diurèse, ionogramme, créatinine
- Autres causes : constipation, hypercalcémie, métastases cérébrales
- Effets indésirables des antiémétiques
- Niveau d'anxiété

Raisonnement clinique · IPA OHO

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Nausées et vomissements chimio-induits

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme K., 39 ans, cancer du sein, a reçu sa première cure (anthracycline et cyclophosphamide). Elle a beaucoup vomi les jours suivants.

La deuxième cure est dans 3 semaines.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Prophylaxie selon les recommandations (anti-NK1, sétron, dexaméthasone, ± olanzapine) avec l'oncologue
- Expliquer le rôle et le calendrier de chaque médicament
- Repas fractionnés, froids, éviter les odeurs fortes
- Relaxation, hypnose pour la composante anticipatoire
- Appel de suivi à J3

Raisonnement clinique · IPA OHO

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Immunothérapie : effets immuno-médiés

Compétences IPA : C1

M. I., 66 ans, mélanome métastatique, reçoit un anti-PD-1 depuis 4 mois. Il signale de la fatigue et des selles plus fréquentes.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Nombre de selles par rapport à l'habitude, sang, douleurs abdominales
- Fatigue, frilosité, prise de poids (dysthyroïdie)
- Éruption, prurit, toux, dyspnée
- Céphalées, troubles visuels (hypophysite)
- Date de début de l'immunothérapie

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Immunothérapie : effets immuno-médiés

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. I., 66 ans, mélanome métastatique, reçoit un anti-PD-1 depuis 4 mois. Il signale de la fatigue et des selles plus fréquentes.

5 selles par jour au lieu d'une, sans sang ; frilosité.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Effets indésirables immuno-médiés : colite et dysthyroïdie
- Colite de grade 2 (+ 4 à 6 selles/jour)
- Possibles à tout moment, même après l'arrêt
- Différentiels : infection (C. difficile), progression tumorale

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Immunothérapie : effets immuno-médiés

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. I., 66 ans, mélanome métastatique, reçoit un anti-PD-1 depuis 4 mois. Il signale de la fatigue et des selles plus fréquentes.

Pas de fièvre, abdomen souple.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- TSH, T4 libre ; cortisol selon le contexte
- NFS, CRP, ionogramme, créatinine, bilan hépatique
- Coproculture, recherche de C. difficile
- Endoscopie si persistance, selon le protocole

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Immunothérapie : effets immuno-médiés

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. I., 66 ans, mélanome métastatique, reçoit un anti-PD-1 depuis 4 mois. Il signale de la fatigue et des selles plus fréquentes.

Colite de grade 2 et hypothyroïdie confirmées.

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Avis oncologique le jour même : suspension de l'immunothérapie, corticothérapie selon protocole
- Substitution thyroïdienne sur prescription
- ETP : signaler tout symptôme nouveau ; carte patient immunothérapie
- Surveillance rapprochée, information des autres soignants
- Recours au réseau de gestion des toxicités

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Douleur cancéreuse

Compétences IPA : C1

M. D., 70 ans, cancer de la prostate avec métastases osseuses, a des douleurs lombaires qui l'empêchent de dormir.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Siège, irradiation, intensité (EN), horaire, facteurs aggravants
- Composante neuropathique (DN4)
- Antalgiques pris, efficacité, effets indésirables
- Sommeil, humeur, autonomie
- Représentations sur la morphine

Raisonnement clinique · IPA OHO

♥ 7

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Douleur cancéreuse

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. D., 70 ans, cancer de la prostate avec métastases osseuses, a des douleurs lombaires qui l'empêchent de dormir.

EN à 7/10 malgré le tramadol ; douleur en ceinture avec fourmillements des jambes.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Douleur mixte : osseuse et neuropathique
- Antalgie insuffisante : palier 3 à discuter
- Drapeau rouge : compression médullaire débutante ?
- Hypercalcémie à évoquer (douleur, constipation, confusion)

Raisonnement clinique · IPA OHO

♦ 7

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Douleur cancéreuse

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. D., 70 ans, cancer de la prostate avec métastases osseuses, a des douleurs lombaires qui l'empêchent de dormir.

Il décrit une faiblesse des jambes depuis la veille.

? Quels examens ? Quel niveau d'urgence ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen neurologique : force, sensibilité, réflexes, sphincters
- Suspicion de compression médullaire = IRM du rachis en urgence
- Calcémie corrigée, fonction rénale
- Corticothérapie et avis radiothérapie ou neurochirurgie selon protocole

Raisonnement clinique · IPA OHO

♣ 7

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Douleur cancéreuse

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. D., 70 ans, cancer de la prostate avec métastases osseuses, a des douleurs lombaires qui l'empêchent de dormir.

Compression écartée ; métastases osseuses douloureuses.

? Quel plan antalgique et de suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Opioïde fort à libération prolongée + interdoses, titration selon protocole
- Prévention systématique de la constipation
- Radiothérapie antalgique à discuter ; traitement de la douleur neuropathique
- ETP : carnet de douleur, interdoses, lever les craintes
- Recours à l'équipe douleur et soins de support

Raisonnement clinique · IPA OHO

♠ 7

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Fatigue et activité physique adaptée

Compétences IPA : C1

Mme F., 52 ans, a terminé sa chimiothérapie pour un cancer du sein il y a 2 mois. Elle se dit « épuisée » et ne reprend pas le travail.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fatigue : intensité (0–10), évolution, retentissement
- Sommeil, humeur, anxiété, douleur
- Activité physique avant et depuis le cancer
- Alimentation, poids
- Traitements en cours (hormonothérapie)

Raisonnement clinique · IPA OHO

♥ 8

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Fatigue et activité physique adaptée

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme F., 52 ans, a terminé sa chimiothérapie pour un cancer du sein il y a 2 mois. Elle se dit « épuisée » et ne reprend pas le travail.

Fatigue à 7/10 ; elle reste allongée une grande partie de la journée.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fatigue liée au cancer, fréquente et persistante
- Causes curables : anémie, hypothyroïdie, dépression, troubles du sommeil, douleur
- Déconditionnement physique (cercle vicieux)
- Effets de l'hormonothérapie

Raisonnement clinique · IPA OHO

♦ 8

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Fatigue et activité physique adaptée

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme F., 52 ans, a terminé sa chimiothérapie pour un cancer du sein il y a 2 mois. Elle se dit « épuisée » et ne reprend pas le travail.

Pas de signe dépressif majeur.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- NFS, ferritine, TSH, ionogramme, glycémie, bilan hépatique
- Anxiété et dépression (HAD)
- Condition physique (test de marche)
- Évaluation nutritionnelle

Raisonnement clinique · IPA OHO

♣ 8

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Fatigue et activité physique adaptée

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme F., 52 ans, a terminé sa chimiothérapie pour un cancer du sein il y a 2 mois. Elle se dit « épuisée » et ne reprend pas le travail.

Le bilan est normal.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Activité physique adaptée : intervention la plus efficace sur la fatigue
- Prescription d'APA, programme de réadaptation, Maison sport-santé
- Gestion de l'énergie, sommeil ; soutien psychologique
- Reprise progressive : temps partiel thérapeutique, médecin du travail
- Réévaluation à 1–3 mois

Raisonnement clinique · IPA OHO

♠ 8

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Dénutrition en oncologie

Compétences IPA : C1

M. E., 68 ans, cancer du pancréas, débute une chimiothérapie. Il a perdu 7 kg en un mois.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Poids actuel et habituel, IMC
- Ingesta (échelle de 0 à 10)
- Nausées, douleur, diarrhée, satiété précoce
- Selles grasses (insuffisance pancréatique exocrine)
- Force musculaire, autonomie

Raisonnement clinique · IPA OHO

♠ 6

9 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Dénutrition en oncologie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. E., 68 ans, cancer du pancréas, débute une chimiothérapie. Il a perdu 7 kg en un mois.

Poids passé de 78 à 71 kg (– 9 % en 1 mois). Ingesta 4/10. Selles grasses.

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dénutrition : perte ≥ 5 % en 1 mois
- Sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 % en 6 mois ou albuminémie ≤ 30 g/L
- Ingesta < 7/10 : apports insuffisants
- Insuffisance pancréatique exocrine probable

Raisonnement clinique · IPA OHO

♦ 6

9 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Dénutrition en oncologie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. E., 68 ans, cancer du pancréas, débute une chimiothérapie. Il a perdu 7 kg en un mois.

Albuminémie 32 g/L, CRP 25 mg/L.

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Albumine à interpréter avec la CRP
- Force de préhension, masse musculaire (sarcopénie)
- Glycémie (diabète pancréatique)
- Évaluation des symptômes digestifs

Raisonnement clinique · IPA OHO

♣ 6

9 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Dénutrition en oncologie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. E., 68 ans, cancer du pancréas, débute une chimiothérapie. Il a perdu 7 kg en un mois.

M. E. « n'a pas faim ».

? Quel plan nutritionnel proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Enrichissement, repas fractionnés, compléments nutritionnels oraux
- Extraits pancréatiques en début de repas, sur prescription
- Contrôle des symptômes (antiémétiques, antalgie)
- Nutrition entérale à discuter selon le projet de soins
- Suivi diététique, pesée hebdomadaire, activité physique

Raisonnement clinique · IPA OHO

♥ 6

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

10 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Thrombose et cancer

Compétences IPA : C1

> *Mme T., 59 ans, cancer de l'ovaire sous chimiothérapie, a le mollet gauche gonflé et douloureux depuis 2 jours.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Douleur, œdème, chaleur ; dyspnée, douleur thoracique
- Facteurs de risque : cancer actif, chimiothérapie, cathéter, alitement, chirurgie récente
- Traitements en cours, anticoagulant prophylactique ?
- Antécédents de thrombose ou de saignement

10 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Thrombose et cancer

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme T., 59 ans, cancer de l'ovaire sous chimiothérapie, a le mollet gauche gonflé et douloureux depuis 2 jours.

> *Mollet gauche augmenté de 3 cm ; pas de dyspnée.*

? Quelle est votre hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Thrombose veineuse profonde probable
- Cancer actif : facteur de risque majeur (score de Wells élevé)
- Embolie pulmonaire si dyspnée, douleur thoracique, tachycardie
- Différentiels : hématome, kyste poplité, érysipèle

10 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Thrombose et cancer

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme T., 59 ans, cancer de l'ovaire sous chimiothérapie, a le mollet gauche gonflé et douloureux depuis 2 jours.

> *SpO_2 97 %, FC 88/min.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Écho-doppler veineux en urgence
- D-dimères inutiles pour exclure si probabilité forte
- NFS-plaquettes, créatinine, hémostase avant anticoagulation
- Angioscanner thoracique si signes d'embolie pulmonaire

10 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Thrombose et cancer

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme T., 59 ans, cancer de l'ovaire sous chimiothérapie, a le mollet gauche gonflé et douloureux depuis 2 jours.

> *TVP proximale confirmée.*

? Quelle prise en charge et quel suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Anticoagulation curative adaptée au cancer (HBPM ou AOD selon situation), sur prescription
- Au moins 6 mois, tant que le cancer est actif
- Surveillance : saignements, plaquettes, interactions
- ETP : injections, signes d'alerte, contention
- Coordination oncologue, médecin vasculaire, infirmier libéral

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

V ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Hémopathie : thérapie ciblée orale

Compétences IPA : C1

M. H., 74 ans, leucémie lymphoïde chronique, prend de l'ibrutinib depuis 6 mois. Il vient pour son suivi infirmier.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Observance, horaires, oublis
- Ecchymoses, saignements, palpitations, diarrhée, arthralgies
- Infections récentes
- Tous les médicaments et compléments (interactions, anticoagulants)
- PA (HTA sous ibrutinib)

V ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Hémopathie : thérapie ciblée orale

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. H., 74 ans, leucémie lymphoïde chronique, prend de l'ibrutinib depuis 6 mois. Il vient pour son suivi infirmier.

Palpitations depuis une semaine. Il prend du millepertuis « pour le moral ».

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fibrillation atriale possible : effet indésirable connu
- Millepertuis : inducteur enzymatique, baisse d'efficacité de l'ibrutinib
- Risque hémorragique si anticoagulation
- Humeur à évaluer

V ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Hémopathie : thérapie ciblée orale

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. H., 74 ans, leucémie lymphoïde chronique, prend de l'ibrutinib depuis 6 mois. Il vient pour son suivi infirmier.

Pouls irrégulier à 110/min.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- ECG
- NFS, ionogramme, créatinine
- PA
- Gravité : malaise, douleur thoracique, dyspnée

V ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Hémopathie : thérapie ciblée orale

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. H., 74 ans, leucémie lymphoïde chronique, prend de l'ibrutinib depuis 6 mois. Il vient pour son suivi infirmier.

FA confirmée.

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Avis hématologue et cardiologue : poursuite ou changement de traitement, anticoagulation
- Arrêt du millepertuis ; vérification des interactions avec le pharmacien
- Soutien de l'humeur
- ETP : saignements, infections, palpitations
- Vaccinations recommandées ; pas de vaccin vivant

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Neuropathie chimio-induite

Compétences IPA : C1

> *Mme O., 56 ans, cancer du côlon, reçoit de l'oxaliplatine. Elle a des fourmillements des doigts au froid.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Symptômes aigus au froid ou persistants entre les cures
- Localisation, intensité, gestes difficiles (boutons, écriture, marche)
- Nombre de cures, dose cumulée
- Diabète, alcool, carence en B12
- Chutes

D ♥

D ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Neuropathie chimio-induite

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme O., 56 ans, cancer du côlon, reçoit de l'oxaliplatine. Elle a des fourmillements des doigts au froid.

> *Les fourmillements persistent entre les cures ; elle a du mal à boutonner son chemisier.*

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Neuropathie cumulative à l'oxaliplatine
- Grade 2 : limite les activités instrumentales
- Peut s'aggraver après l'arrêt (phénomène de coasting)
- Retentissement fonctionnel et sur la qualité de vie

D ♣

D ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Neuropathie chimio-induite

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme O., 56 ans, cancer du côlon, reçoit de l'oxaliplatine. Elle a des fourmillements des doigts au froid.

> *Réflexes achilléens diminués.*

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Sensibilité, proprioception, équilibre
- Échelle de neurotoxicité ; DN4 si douleur
- Glycémie, B12 selon le contexte
- Risque de chute

D ♠

D ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Neuropathie chimio-induite

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme O., 56 ans, cancer du côlon, reçoit de l'oxaliplatine. Elle a des fourmillements des doigts au froid.

> *L'oncologue envisage une adaptation.*

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Réduction de dose ou pause de l'oxaliplatine, décidée par l'oncologue
- Prévention : éviter le froid, gants, boissons tièdes
- Sécurité : chutes, brûlures (eau chaude)
- Douleur neuropathique : duloxétine possible, sur prescription
- Kinésithérapie, ergothérapie

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Après-cancer

Compétences IPA : C1

> *M. R., 58 ans, a terminé le traitement d'un cancer du poumon il y a 6 mois. Il vient pour la consultation de fin de traitement.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Séquelles : dyspnée, douleur, fatigue, neuropathie
- Tabac, alcool, activité physique, alimentation
- Humeur, peur de la récidive
- Situation professionnelle et sociale
- Compréhension du suivi prévu

Raisonnement clinique · IPA OHO

♥ R

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Après-cancer

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. R., 58 ans, a terminé le traitement d'un cancer du poumon il y a 6 mois. Il vient pour la consultation de fin de traitement.

> *Il a repris 5 cigarettes par jour et appréhende chaque scanner.*

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Reprise du tabac : récidive, second cancer
- Peur de la récidive, anxiété avant les examens
- Besoin d'un programme personnalisé de l'après-cancer
- Réinsertion professionnelle à accompagner

Raisonnement clinique · IPA OHO

♦ R

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Après-cancer

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. R., 58 ans, a terminé le traitement d'un cancer du poumon il y a 6 mois. Il vient pour la consultation de fin de traitement.

> *Il est essoufflé à l'effort.*

? Quelles évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Calendrier de surveillance oncologique
- EFR selon le contexte
- Anxiété-dépression (HAD)
- Dépistage des autres cancers, facteurs de risque cardiovasculaire

Raisonnement clinique · IPA OHO

♣ R

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Après-cancer

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. R., 58 ans, a terminé le traitement d'un cancer du poumon il y a 6 mois. Il vient pour la consultation de fin de traitement.

> *M. R. veut « reprendre une vie normale ».*

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt du tabac : accompagnement renforcé
- Activité physique adaptée, réhabilitation respiratoire
- Soutien psychologique, groupes de patients
- Retour au travail : médecin du travail, temps partiel thérapeutique
- Programme d'après-cancer partagé avec le médecin traitant

Raisonnement clinique · IPA OHO

♠ R

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

A ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Soins palliatifs précoces

Compétences IPA : C1

Mme P., 71 ans, cancer du poumon métastatique en progression après deux lignes de traitement, est plus fatiguée et essoufflée.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dyspnée, douleur, fatigue, anorexie, anxiété
- État général (OMS), autonomie
- Compréhension de la maladie et du pronostic
- Souhaits, valeurs, lieu de vie souhaité
- Entourage, personne de confiance

Raisonnement clinique · IPA OHO

♥ A

A ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Soins palliatifs précoces

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme P., 71 ans, cancer du poumon métastatique en progression après deux lignes de traitement, est plus fatiguée et essoufflée.

Elle dit : « Je ne veux pas finir à l'hôpital. »

? Quels besoins identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Soins palliatifs précoces : bénéfice sur la qualité de vie
- Anticipation : directives anticipées, personne de confiance
- Symptômes à contrôler
- Faisabilité d'une fin de vie à domicile

Raisonnement clinique · IPA OHO

♦ A

A ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Soins palliatifs précoces

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme P., 71 ans, cancer du poumon métastatique en progression après deux lignes de traitement, est plus fatiguée et essoufflée.

SpO_2 92 % au repos ; épanchement pleural connu.

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Échelle de symptômes (ESAS)
- Ressources et épuisement de l'aidant
- Faisabilité du maintien à domicile
- Balance bénéfice-risque des traitements, avec l'oncologue

Raisonnement clinique · IPA OHO

♣ A

A ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Soins palliatifs précoces

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme P., 71 ans, cancer du poumon métastatique en progression après deux lignes de traitement, est plus fatiguée et essoufflée.

Elle souhaite rester chez elle le plus longtemps possible.

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Équipe ou réseau de soins palliatifs ; HAD si besoin
- Directives anticipées, personne de confiance
- Prescriptions anticipées personnalisées (dyspnée, douleur, angoisse)
- Soutien de l'aidant, coordination médecin traitant et infirmier libéral
- Réévaluation régulière du projet de soins

Raisonnement clinique · IPA OHO

♠ A

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

Drapeau rouge

Choisissez une situation du jeu et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

Leadership & recherche

À partir de la dernière situation jouée, proposez une action d'amélioration des pratiques (protocole, audit, formation) ou formulez une question de recherche (PICO).

Compétences C5 · C6. Si le groupe valide, ce joker remplace une carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

Cœur · Recueillir
Anamnèse, écoute, contexte de vie

Carreau · Repérer & hypothèses
Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges

Trèfle · Vérifier
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

Pique · Agir & suivre
Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Thérapie orale : capécitabine
3	Neutropénie fébrile
4	Mucite et radiochimiothérapie
5	Nausées et vomissements chimio-induits
6	Immunothérapie : effets immuno-médiés
7	Douleur cancéreuse
8	Fatigue et activité physique adaptée
9	Dénutrition en oncologie
10	Thrombose et cancer
V	Hémopathie : thérapie ciblée orale
D	Neuropathie chimio-induite
R	Après-cancer
A	Soins palliatifs précoces

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · OHO

IPA · Master